

Información Paciente

Nombre : Carlos Rolando Avila Moraga
Edad : 74a 7m 20d
Dirección : Cerro Hornilla 1748

Rut : 6.234.433-4
Fecha Nacto: 15/06/1951
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1134680
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 9901 6710

N° Epicrisis
470823

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Geriatria

Fecha Ingreso : 28/12/2025 14:33

Días Estadía: 38

Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Egreso : 04/02/2026 19:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

disnea

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

RESUMEN 02/02/26

AM: Fibrosis pulmonar UIP dg 2023 extrasistema, TVP 2011, insuficiencia venosa, depresión.
Fcos: Sertralina 100 mg día, hidroclorotiazida 25 mg día, hierro 200 mg cada 12 horas, spiolto 2 puff noche.
Qx: Apendicectomía, hernioplastia inguinal
Alergias: -
Hábitos: Tabaco: suspendido hace > 15 años. Antes 2 cig día OH: ocasional Drogas: no
Ant Fam: Hermano Fibrosis pulmonar.
Exposición: Trabajó 30 años en industria de vidrio y cerámica sin elementos de protección personal.
Social: Viudo hace 1 año y medio. Vive solo, Barthel 100/100

RESUMEN

Consulta el 26/12/25 por cuadro de disnea progresiva, dolor toracico retroesternal opresivo, sin irradiación ni síntomas neurovegetativos.

A su ingreso desaturando hasta 75%, polipneico, se describe con crépitos bibasales.

Dentro de laboratorio destaca PPII elevados (GB:11.470 Hb:12.4 RAN:8.300 PLQ:541.000 PCR:182.8) AKI (Crea:1.00 BUN:24.2 Na:136 K:3.72 Cl:101) coagulopatía INR 1.31. Curva de TUS 105 --> 74, ECG sin signos de isquemia. Estudio microbiológico con PV (-). Angiotac sin TEP, con EPID tipo FPI y neumopatía multifocal de probable etiología inflamatoria infecciosas. Adenopatías mediastínicas reactivas y signos de HTP.

Se hospitaliza con diagnóstico de NAC multifocal severa, y se traslada a UGA

Se inicia Tazonam + Azitromicina, sin embargo, a las 24 horas de ingreso requiere soporte con CNAF. Completa 5 días de antibioticoterapia con mala respuesta, desaturación hasta 40% a pesar de CNAF a 60%/45 flujo, por lo que se escala a Imipenem + Vancomicina (HCs negativos), se intenta VMNI y ante persistencia de mala mecánica ventilatoria se decide IOT y traslado a UPC el 05/01.

Evolución por sistemas

Hemodinámico: Requirió NAD + vasopresina de shock séptico, además ecoscopia con signos de falla derecha e HTP que se manejó con BH negativos mediante TRR. Logra suspender vasoactivos tras 48 horas de reanimación. AL ingreso TUS (+) con curva positiva interpretado en contexto de posible IAM tipo 2. Tras estabilización tiende a la hipertensión en ajuste de VDO y

Fecha Epicrisis : 04/02/2026 19:44

terapia depleitiva por VEC aumentado. Actualmente macrohdm estable, autosostenido sin conflicto perfusional.

Ventilatorio: Antecedente de fibrosis pulmonar, patrón UIP. Ingresó por exacerbación con req. de IOT por 10 días + BNM por 24 horas en contexto de neumonía grave. IOT 04/10- 14/01. EPID patrón UIP exacerbada por NAC multilobar. Presentó severo conflicto de intercambio, requiriendo BMN a 48 horas. Sale inicialmente a BPAP, luego CNAF y desde el 18/01 a NRC. A su ingreso a UTIM consolidando weaning con req de O2 bajos por NRC. El 21/01 tras deterioro neurológico por ACV con aumento de requerimientos de oxígeno hasta CNAF. Ev por equipo de BP le impresiona obs silicosis, ajusta indicación de BD, indica seguimiento ambulatorio al alta. Sin indicación de antifibróticos. Actualmente con NRC 1 lt. KNTR full rehab.

Neurológico: el 21/01 paciente con hemiparesia izquierda, TAC de cerebro + AngioTAC sin sangrados, sin grandes vasos ocluidos. Evaluado por neuro stroke se decidió trombólisis según protocolo NINDS dado paciente en ventana. Procedimiento sin conflictos. Mantiene medidas de neuroprotección. Se mantiene con estatinas a dosis alta y AP.

Infeccioso: Al ingreso NAC multilobar sin microbiología aislada, sin respuesta a Tazonam por lo que se escala a Imipenem + Vancomicina y se agrega hidrocortisona por shock séptico. Estudio microbiológico con VIH (-), HC 1 y 2 (-), CAET con C. Tropicalis interpretado como colonización. TAC de contro I 07/01 sin cambios con respecto a previo. Completa 7 días del esquema descrito y 7 días de mineralocorticoide con decalaje a PDN desde el 14/01. Actualmente, sin ATB, afebril, sin elevación de ppii.

Renal: AKI KDIGO III con acidosis metabólica severa y anúrico, requiere TRR desde el 05/01 con BH negativos en contexto de ICC derecha con congestión sistémica. Tras extubación, recupera diuresis y se mantuvo con terapia depleitiva a base de tiazidas. 19/01 se retira CH D. Además tendió a la hipocalcemia con requerimiento de reposición EV. Actualmente sin conflicto.

Gastrointestinal: Hepatitis congestiva con PPHH hepatocelular, a la baja tras resolución de shock.

Rehabilitación:

- FNA: Con disfagia FILS-7, mantiene alimentación enteral mixta, en seguimiento por FNA.
- Nutricional: recibiendo alimentación mixta, licuado + líquidos espesos. En seguimiento.
- Motor: logrando SBC previamente, actualmente en reposo absoluto para manejo de ACV, progresión de inclinación de cabecera según compromiso motor izquierdo.

EN PLAN DE CONTINUAR REHABILITACION Y LOGRAR DESTETE DE O2 EN HSJM

MICROBIOLOGÍA

(23/01) VDRL N/R

(16/01) URC >30.000 UFC/mL

(14/01) Hisopado rectal Carbapenemasas (-)

(05/01) Portaciones: Enterococcus faecium Van B, Carbapenemasas (-), CAET TG levaduras escasas, Cultivo Candida tropicalis >200.000 UFC/mL, VIH N/R, VHB/VHC N/R

(04/01) hemocultivo I y II (-) Panel Viral Respiratorio IFD (-) SARS-COV-2 (-)

IMÁGENES

(03/02/26) Ecocardiograma Doppler: 1. Hipertrofia ventricular izquierda concéntrica leve con función sistólica global conservada. 2. Leve dilatación de la aurícula izquierda. 3. Cambios degenerativos de válvulas aórtica y mitral, con insuficiencia aórtica leve. 4. Cavidades derechas normales. 5. Insuficiencia tricuspídea leve. 6. Hipertensión pulmonar (PSAP 40 mmHg). 7. Ateromatosis aórtica.

(25/01/26) Angio RNM cerebro: Infarto subagudo precoz frontoparietal derecho en territorio de ACM, sin signos de transformación hemorrágica. Microangiopatía no confluyente de sustancia blanca supratentorial.

(07/01/26) TAC TAP: Neumopatía multifocal de similar extensión que en estudio previo del 4 de enero.

Enfermedad fibrótica conocida del parénquima pulmonar con los caracteres de UIP. Leve cardiomegalia con predominio de dilatación de cavidades derechas hallazgo que se asocia aumento de calibre del tronco la arteria pulmonar, manifestación de hipertensión pulmonar y de insuficiencia cardíaca derecha. Adenopatías mediastínicas e hiliares probablemente reactivas sin cambios. Ascitis y edema difuso del mesenterio asociado a edema del tejido celular subcutáneo y leve derrame pleural bilateral

Fecha Última Actualización: 04-02-2026 19:44:37

Página 3 de 4

que impresionan en contexto de anasarca. Retardo en eliminación del medio de contraste en ambos riñones manifestación de nefropatía. Impregnación heterogénea del parénquima hepático y edema periportal que impresionan en contexto de hepatopatía congestiva.

(27/12/25) AngioTAC torax: Examen sin signos de TEP hasta nivel segmentario. Enfermedad pulmonar intersticial fibrótica difusa con patrón consistente con FPI. Neumopatía multifocal de probable etiología inflamatoria infecciosa. Adenopatías mediastínicas e hiliares de probable carácter reactivo. Signos sugerentes de hipertensión pulmonar.

Diagnóstico de Egreso

NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA -
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA -
ENFERMEDAD PULMÓNAR INTERSTICIAL, NO ESPECIFICADA -
ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESPECIFICADO COMO HEMORRAGICO O ISQUEMICO -

Condición de Egreso

Traslado

Egreso con Catéter Doble J:NO

Paciente en BCG, HDN estable, normocárdico, normotenso. Afebril, 1 Lt de O2 por NRC.

Plan Post Alta

INDICACIONES

GENERALES

Reposo relativo asistido, cabecera de 30°
Régimen licuado + líquidos espesos (goma). Enteral con Osmolite a 60cc/hr por SNG + agua 40cc/h
O2 para Sat >92%
HGT cada 6 horas
BH cada 12 horas
Kine R + M, FNA.
Invasivos: SNG

MEDICAMENTOS

Spiolto 2 inhalaciones/día (PLT)
Bromuro de ipratropio 2 puff cada 8 hrs con aerocámara.
Atorvastatina 80 mg/día SNG
Aspirina 100 mg c/ 24 hrs por SNG
Sertralina 50 mg por SNG - AM
Enoxaparina 40 mg c/ 24 hrs SC

SOS:

Si insomnio - Quetiapina 12.5 mg por SNG - PM
Paracetamol 1 gr EV SOS si fiebre o dolor
Salbutamol SOS

Manejo activo

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Nutrición Enteral

Medicamentos :

Controles

Fecha Epicrisis : 04/02/2026 19:44

Página 3 de 4



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 04-02-2026 19:44:37

Página 4 de 4

INTERNO

Becado/Residente

Agustín Felipe Muga Vaccarella

Médico Tratante (Staff)